

LES ANGINES

I. Introduction

- Inflammation infectieuse de l'amygdale palatine
- > 50% d'origine virale
- ATB → RAA
- TDR : Strepto β hémolytique A
- Plusieurs formes cliniques
- Complications graves
- Intérêt de la prévention : Traitement des angines aiguës

Rappels

II. Épidémiologie :

- 50 à 90% des angines sont virales
- Pic d'incidence : 5 – 15 ans
- L'angine streptococcique de type A :
 - ❖ **Enfant < 3 ans** : Exceptionnelle
 - ❖ **Enfant > 3 ans** : 25 à 40%
 - ❖ **Adulte** : 10 à 25%

Etiologies (agents pathogènes)

III. Clinique

- Dysphagie fébrile
- Odynophagie parfois des otalgies réflexes
- Jeune enfant : Vomissement, diarrhée, gêne respiratoire
- Pharynx : Type d'angines +++
- Examen ORL complet
- Examen somatique : Eruption, HSMG, ADP
- Score de Mac Isaac :

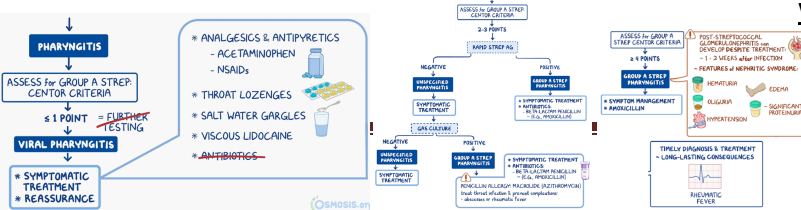
Item	Point
❖ Fièvre > 38	1
❖ Atteinte amygdalienne (exsudat, hypertrophie)	1
❖ ADP cervicales douloureuses	1
❖ Absence de toux et de rhinorrhée	1
❖ Age :	
↳ 15 – 44 ans	0
↳ ≥ 45 ans	-1

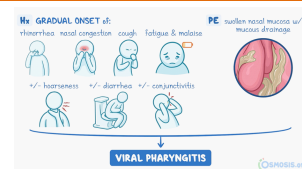
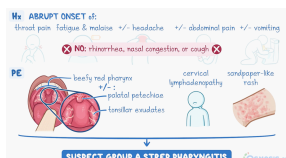
Résultats :

- **-1, 0 ou 1** : Angine streptococcique peu probable, pas de test de dépistage, nécessaire. Pas d'indication d'ATB
- **≥ 2** : Faire un TDR
 - ✓ TDR positif → Traitement ATB
 - ✓ TDR négatif et absence de facteurs de risque de RAA : Pas d'ATB
 - ✓ TDR négatif et facteurs de RAA : ATB

Principales caractéristiques cliniques et épidémiologiques des angines à SGA et des angines

virales



	Angine à SGA	Angine virale
Epidémiologie	✓ Epidémie – hiver et début printemps ✓ Age : pic d'incidence entre 5 et 15 ans (survenue possible dès 3 ans)	
Signes fonctionnels ou généraux	✓ Début brusque ✓ Odynophagie intense ✓ Absence de toux ✓ Fièvre élevée	✓ Début progressif ✓ Dysphagie modérée ou absente ✓ Présence de toux, coryza, diarrhée, éternuement
Signes physiques	 ✓ Erythème pharyngé intense ✓ Purpura du voile ✓ Exsudat ✓ ADP satellite sensible ✓ Eruption scarlatiniforme	✓ Vésicules (herpès, coxsackie ou gingivo-stomatite herpétiforme) ✓ Eruption évocatrice d'une maladie virale ✓ Conjonctivite

IV. Formes cliniques :

1. Angine érythémateuse :

- Virale : Rougeole / Oreillons / Rubéole / Grippe / Varicelle / Polio ...

- Bactérienne

- Scarlatine :

- Maladie infectieuse d'origine microbienne
- Fièvre à 40°C avec vomissements
- Aspect rouge vif du pharynx
- Rash scarlatineux aux plis de flexion

- Syndrome de Kawasaki : Fièvre, chéilite, conjonctivite, exanthème, Gammaglobuline

2. Angine érythémato-pultacée :

- Présence sur des amygdales rouge vif d'un exsudat pultacé, facilement dissocié, ne débordant pas la surface amygdalienne
- Signes fonctionnels sont en général plus marqués
- Outre l'origine virale dont la MNI ou le strepto A, l'étiologie peut-être un strepto non A, staph, pneumocoque, Pasteurella Tularensis ou toxoplasma gondii

3. Angine pseudomembraneuse et membraneuse :

- L'examen du pharynx montre des fausses membranes nacrées, extensives, pouvant déborder la région amygdalienne, le voile et ses piliers
- Il faut penser en particulier à la MNI (EBV) Lorsque :
 - ✓ L'angine se prolonge et qu'il s'y associe des ADP diffuses
 - ✓ SMG, Asthénie marquée
 - ✓ Purpura du voile
 - ✓ Les fausses membranes se décollent facilement
 - ✓ NFS peut montrer une hyperGB avec mononucléose hyperbasophile
 - ✓ Cytolyse hépatique et surtout sérologie MNI en font le diagnostic
 - ✓ Le traitement est symptomatique
- La diphtérie, autre fois étiologie classique de cette forme clinique est devenue exceptionnelle depuis la vaccination obligatoire

QE!!

QE!!

QE!!

- Il faut cependant toujours y penser devant une angine pseudomembraneuse rapidement extensive avec pâleur et asthénie inhabituelle
- Les fausses membranes sont adhérentes, non dissociables
- La sérothérapie antidiphtérique **QE!!**
- La recherche de *Corynebacterium diphtheriae* doivent être mis en route immédiatement
- Afin d'éviter les formes malignes, autrefois de pronostic très grave
- Une antibiothérapie doit être associée

4. Angine vésiculeuse :

- Une ulcération du revêtement épithélial, succédant à une éruption vésiculeuse, fugace au niveau des amygdales et des piliers
- L'angine herpétique, due au virus herpès simplex habituellement de type 1
- Son début est brutal par une température à 39-40° avec frissons et dysphagie douloureuse intense
- Herpès narinaire ou labial est fréquemment associé
- L'évolution est bénigne en 4 à 5 jours, sans complications ni séquelles
- Le traitement est uniquement symptomatique +++

5. Angine ulcéro-nécrotique

Angine de Vincent

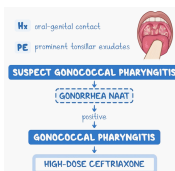
Syphilis

VIH

Gonocoque

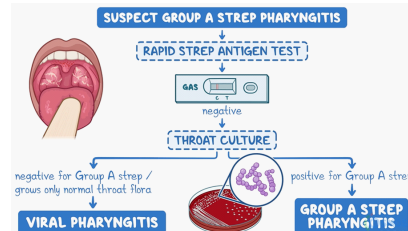
Tuberculose

Anaérobies sur terrain ID



Paraclinique

- ❖ NFS
- ❖ Sérologie TPHA – VDRL, VIH, EBV
- ❖ MNI test, PBD
- ❖ Transaminases
- ❖ TDR du strepto A
- ❖ Bactériologie de prélèvement de gorge



TDR. Test de détection rapide

Score de Mac Isaac:

Fièvre > 38 °C	1 point
Absence de toux	1 point
Adénopathies cervicales sensibles	1 point
Atteinte amygdalienne: augmentation du volume ou un exsudat	1 point
Age	de 15 à 44 ans: 0 point ≥ 45 ans: -1 point

- Négatif: -1, 0 ou 1: Angine streptococcique peu probable
- Positif: ≥ 2: Faire un TDR

VI. Complications :

1. Liées au streptocoque :

a. Rhumatisme articulaire aigu :

- Physiopathologie ?
- Absence d'ATCD d'angine dans 30 à 50% des cas
- Endémie pays émergents
- Risque 1 à 3% sérotype M1, M3, M18
- En France : 10 nouveaux cas / an
- Maroc ???
- Manifestations articulaires : Arthrite, arthralgies
- Manifestations cardiaques : Cardite, valvulopathies
- Manifestations nerveuses
- Autres : Fièvre, douleur abdominale, VS, hyperleucocytose

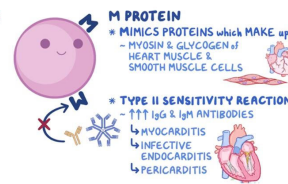
b. Glomérulonéphrite aiguë :

POST-INFECTIOUS SEQUELAE

* ARISE even after BACTERIA ELIMINATED from BODY

STREP PHARYNGITIS

ACUTE RHEUMATIC FEVER



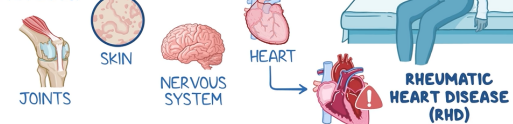
ACUTE RHEUMATIC FEVER (ARF)

* SYSTEMIC INFLAMMATORY CONDITION

↳ AFTER INFECTION w/ GROUP A STREPTOCOCCUS (GAS)

* thought to be IMMUNE-MEDIATED

* AFFECTS:



Hx

- * Teenager, young adults
- * Recent group A strep infection

PE

* Migratory, asymmetric polyarthritides

* New heart murmur, pericardial friction rub

* Subcutaneous nodules

* Erythema marginatum

* Sydenham chorea

SUGGESTIVE of RHEUMATIC FEVER

ASSESS JONES CRITERIA



RHEUMATIC FEVER

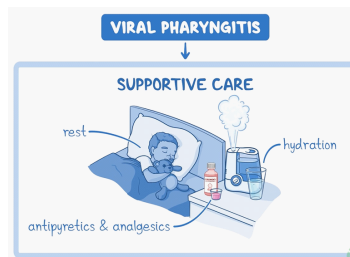
- ✓ Céfuraxime – axétil
- ✓ Macrolides si allergie au beta lactamines

b. Angine blanche :

- MNI : ATG , antipyrétiques +/- cortico , pas d'amoxicilline +++
- Diphtérie :
 - Péni G à forte dose : 20 à 50 000 UI / kg / j
 - Sérothérapie : 20 000 à 100 000 UI
 - Vaccination
 - Isolement / déclaration obligatoire / dépistage de l'entourage

c. Angine vésiculeuse :

- Antalgiques
- Anesthésie locale
- SNG
- Règles d'hygiène de vie

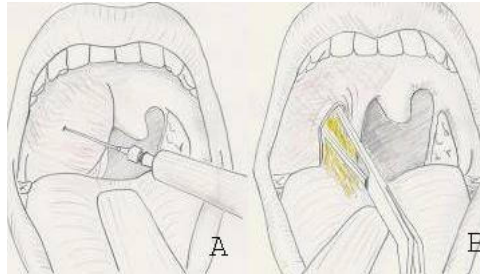


d. Angine ulcéro-nécrotique :

- Angine de Vincent :
- Amoxicilline – Ac clav 3g/j pdt 10j
- Bain de douche
- Syphilis : Péni G retard 2.4 MU

e. Complications septiques loco-régionales :

- ATB parentérale :
 - ✓ Probabiliste :
 - C3G + Aminoside + Flagul
 - Amoxicilline-ac clav + Aminoside
 - ✓ Puis selon l'antibiogramme
- Drainage chirurgical



IX. Indications de l'amygdalectomie :

- ✓ Angines récurrentes > 3/an ou 5 / 2 ans QE!!
- ✓ Angines avec retentissement staturo-pondéral et / ou scolaire important
- ✓ Angine cryptique : Amygdalite chronique
- ✓ Syndrome post-streptococcique
- ✓ Abscès péri-amygdalien récurrent
- ✓ Obstruction pharyngée chronique
- ✓ Hypertrophie amygdalienne avec troubles respiratoire obstructifs
- ✓ Biopsie / exérèse d'un amygdale ulcéré



X. Conclusion

- ❖ Multitude des formes cliniques
- ❖ ATB ciblée
- ❖ Examen clinique complet
- ❖ Complications à rechercher systématiquement
- ❖ Amygdalectomie : indications bien réfléchie

